



ТОВ "КАПІТАЛ"
Ліцензія МОЗ України
АГ №599781 від 17.01.2012

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Код закладу за ЗКПО: 32381903

Універсальна клініка Оберіг
Україна, 03057, м. Київ,
вул. Зоологічна, 3, корпус "в" і "г"

(044) 521-30-03
невідкладна допомога 3003

5213003@oberig.ua
www.oberig.ua

ВИПИСНИЙ ЕПІКРИЗ

Пацієнт: **Жерліцина Анастасія Станіславівна, 46 р.**

Стационарна картка № 00054

Дата: **25.01.2023**

Знаходилась на стаціонарному лікуванні з 13.01.2023 18:29 по 25.01.2023 року

СКАРГИ: Скарги на слабкість, сонливість, головний біль.

КЛІНІЧНИЙ ДІАГНОЗ: Злоякісне новоутворення матки, не уточненої локалізації cT2NxM1 (печінка, очеревина) клінічна група IV ECOG 2 (морфологічні верифікація сумнівна через відсутність проведеного імуногістохімічного дослідження та виявлення в пухлині специфічних рецепторів EGFR). Стан після ПХТ.

Синдром задньої обратимої енцефалопатії (Posterior reversible encephalopathy syndrome - PRES) як побічного ефекту лікування Вотреїнтом.

Цукровий діабет, не виключено, індукований глюкокортикоїдами, вперше виявлений в стані субкомпенсації (на даний час на тлі застосування глюкокортикоїдів.).

Анемія хронічних захворювань.

АНАМНЕЗ ЗАХВОРЮВАННЯ: На момент госпіталізації онкологічний діагноз у пацієнтки не був верифікований. Пацієнтка з літа 2022 року лікується з приводу лейоміосаркоми матки T2NxM1 (печінка, очеревина, головний мозок?) у клініці "Інновація". 29.08.22 проводилась біопсія метастатичного вузла в печінці: закльовчення - більше даних за метастаз лейоміосаркоми; ІГХ не виконувалась. Проведено 4 курси ПХТ (гемцитабін+доцетакам+авастин),

Після курсу хіміотерапії на початку січня 2023 року було розпочате лікування препаратом Вотреїнт. Через короткий проміжок часу після початку прийому препарату вотреїнт пацієнтку почав турбувати головний біль, який посилювався у горизонтальному положенні, з кожним днем посилювався і зрештою став постійним. Щоб зменшити головний біль, пацієнтка приймала різні знеболюючі ліки та ліки від тиску, які приносили тимчасове полегшення. Пацієнтка пам'ятає, що робила 12.01.2023, але дуже погано пам'ятає події 13.01.2023. Зі слів матері, 13.01.2023 близько 16 год знайдена вдома непритомною зі слідами піни біля рота і бригадою НМД доправлена в клініку в Клініку "Оберіг".

АНАМНЕЗ ЖИТТЯ: Туберкульоз, венеричні захворювання заперечує. Зі слів пацієнтки хворіла на гепатит багато років тому. Алергічний анамнез не обтяжений. В анамнезі артеріальна гіпертензія відсутня.

СТРАХОВИЙ АНАМНЕЗ: зі слів пацієнтки, протягом останніх 12 місяців на л/л не перебувала.

РЕЗУЛЬТАТИ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: 13.01.2023...Електроліти крові (EasyStat)

Електроліти крові (K⁺, Na⁺, Cl⁻): Na⁺ - 139,5 mmol/L, K⁺ - 3,77 mmol/L, Cl⁻ - 100,9 mmol/L;

13.01.2023...КЛІНІЧНИЙ АНАЛІЗ КРОВІ

Загальноклінічний аналіз крові (ШОЕ, параметри аналізатора, лейкоцитарна формула): Лейкоцити (WBC) - 9,83 x10⁹/л, Еритроцити (RBC) - 4,58 x10¹²/л, Гемоглобін (HGB) - 121 г/л, Гематокрит (HCT) - 39,5 %, Тромбоцити (PLT) - 150 x10⁹/л, Середній розмір еритроцита (MCV) - 86,2 фл, Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) - 26,4 пг, Середня конц.гемоглобіну в еритроцитах (MCHC) - 306 г/л, ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПОПУЛЯЦІЇ ЛЕЙКОЦИТІВ (АНАЛІЗАТОР) -, Відносна к-ть нейтрофілів NEUT% - 92,7 %, Відносна к-ть лімфоцитів LYM % - 4,8 %, Відносна к-ть моноцитів MONO% - 1,9 %, Відносна к-ть еозинофілів EO % - 0,1 %, Відносна к-ть базофілів BASO % - 0,5 %, Абсолютна к-ть нейтрофілів NEUT # - 9,11 Г/л, Абсолютна к-ть лімфоцитів LYM # - 0,47 Г/л, Абсолютна к-ть моноцитів MONO # - 0,19 Г/л, Абсолютна к-ть еозинофілів EO # - 0,01 Г/л, Абсолютна к-ть базофілів BASO # - 0,05 Г/л, Розподіл еритроцитів за об'ємом, станд відхилення RDW-SD - 68,2 фл, Розподіл еритроцитів за об'ємом, коеф. варіації RDW-CV - 24 %, Розподіл тромбоцитів PDW - 10,4 фл, Середній об'єм тромбоцитів MPV - 9,5 фл, Коеф. великих тромбоцитів P-LCR - 22,8 %, Тромбоцит PCT - 0,14 %, ШОЕ (ESR), метод Вестергрена - 63 мм/год, ЛЕЙКОЦИТАРНА ФОРМУЛА (МАНУАЛЬНО) -, Паличкаядерні нейтрофіли (band neut%) - 15 %, Сегментоядерні нейтрофіли (segm.neut %) - 76 %, Моноцити (mon %) - 2 %, Лімфоцити (lym %) - 7 %, Еозинофіли (eo %) - 0 %;



ТОВ "КАПІТАЛ"
Ліцензія МОЗ України
АГ №599781 від 17.01.2012

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Код закладу за ЗКПО: 32381903

Універсальна клініка
Україна, 03057, м. Київ,
вул. Зоологічна, 3, корпус "в" і "г"

(044) 521-30-03
невідкладна допомога 3003

5213003@oberig.ua
www.oberig.ua

ВИПИСНИЙ ЕПІКРИЗ

Пацієнт: **Жерліцина Анастасія Станіславівна, 46 р.**

Стаціонарна картка № 00054

Дата: **25.01.2023**

13.01.2023...Біохімічні дослідження

Аланінамінотрансфераза (ALT) - 32,00 U/L; Аспартатамінотрансфераза (AST) - 49,60 U/L; Гама-глутаматтрансфераза (GGT) - 96,90 U/L; Лужна фосфатаза (ALP) - 296,00 U/L; Лактатдегідрогеназа (LDH) - 630,60 U/L; Білірубін загальний (Bilirubin total) - 12,30 $\mu\text{mol/L}$; Білірубін прямий (Bilirubin direct) - 5,20 $\mu\text{mol/L}$; Сечовина (Urea) - 3,12 mmol/L; Холінестераза (CHE) - 6 290 U/L; Креатинін: Креатинін (Creatinine) - 87,14 $\mu\text{mol/L}$; Оцінка швидкості клубочкової фільтрації - 68,7 ml/min; Сечова кислота (Uric acid) - 307,10 $\mu\text{mol/L}$; Альбумін (Albumin) - 40,67 g/L; Примітка - ;

13.01.2023...Визначення групи крові та резус-фактору (гельфільтрація)

Визначення групи крові і резус-фактора (метод гельфільтрації): Група крові - 0 (I), Резус-фактор - Rh(D) (-) негативний, Контрольні матеріали - DiaClon ABO/D+reverse grouping for patients (LOT 50092.16.04) придатні до 2023.07); Стандартні еритроцити КМЦК А (II) Rh+серія №08 придатні до 23/01/2023; B(III) Rh+серія №08 придатні до 23/01/2023 .;

14.01.2023...Дослідження системи гемостазу

Коагулограма (INR, TT, APTT, BT): Дослідження системи гемостазу (Sysmex 600) - , Протромбіновий час (PT) - 12,3 sec, Протромбіновий індекс - 91 %, Міжнародне нормалізоване співвідношення (MNC) INR - 1,10 , Тромбіновий час (TT) - 19,6 сек, АЧТЧ (активованний частковий тромбопластиновий час) APTT - 27,4 sec, Фібриноген (Fg) - 3,42 g/L;

14.01.2023...Біохімічні дослідження

С- реактивний білок (кількісно) (CRP) - 44,14 mg/L; Примітка - ;

17.01.2023...Електроліти крові (EasyStat) (Гончарук Л. І.)

Електроліти крові (K⁺, Na⁺, Cl⁻): Na⁺ - 135,6 mmol/L, K⁺ - 3,7 mmol/L, Cl⁻ - 104,1 mmol/L;

17.01.2023...КЛІНІЧНИЙ АНАЛІЗ КРОВІ

Загальноклінічний аналіз крові (параметри аналізатора, лейкоцитарна формула): Лейкоцити (WBC) - 11,02 $\times 10^9/\text{л}$, Еритроцити (RBC) - 4,04 $\times 10^{12}/\text{л}$, Гемоглобін (HGB) - 107 г/л, Гематокрит (HCT) - 35,5 %, Тромбоцити (PLT) - 198 $\times 10^9/\text{л}$, Середній розмір еритроцита (MCV) - 87,9 ф/л, Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) - 26,5 п/г, Середня конц.гемоглобіну в еритроцитах (MCHC) - 301 г/л, ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПОПУЛЯЦІЇ ЛЕЙКОЦИТІВ (АНАЛІЗАТОР) - , Відносна к-ть нейтрофілів NEUT% - 76,9 %, Відносна к-ть лімфоцитів LYM % - 15,1 %, Відносна к-ть моноцитів MONO% - 7,5 %, Відносна к-ть еозинофілів EO % - 0 %, Відносна к-ть базофілів BASO % - 0,5 %, Абсолютна к-ть нейтрофілів NEUT # - 8,47 Г/л, Абсолютна к-ть лімфоцитів LYM # - 1,66 Г/л, Абсолютна к-ть моноцитів MONO # - 0,83 Г/л, Абсолютна к-ть еозинофілів EO # - 0 Г/л, Абсолютна к-ть базофілів BASO # - 0,06 Г/л, Розподіл еритроцитів за об'ємом, станд відхилення RDW-SD - 73,9 ф/л, Розподіл еритроцитів за об'ємом, коеф. варіації RDW-CV - 23,9 %, Розподіл тромбоцитів PDW - 12,2 ф/л, Середній об'єм тромбоцитів MPV - 10,1 ф/л, Коеф.великих тромбоцитів P-LCR - 28,3 %, Тромбоцит PCT - 0,2 %, ЛЕЙКОЦИТАРНА ФОРМУЛА (МАНУАЛЬНО) - , Паличкаядерні нейтрофіли(band neut%) - 5 %, Сегментоядерні нейтрофіли (segm.neut %) - 72 %, Моноцити (mon %) - 7 %, Лімфоцити (lym %) - 16 %, Еозинофіли (eo %) - 0 %;

17.01.2023...Біохімічні дослідження

С- реактивний білок (кількісно) (CRP) - 12,74 mg/L;

19.01.2023...КЛІНІЧНИЙ АНАЛІЗ КРОВІ

Загальноклінічний аналіз крові (ШОЕ, параметри аналізатора, лейкоцитарна формула): Лейкоцити (WBC) - 12,84 $\times 10^9/\text{л}$, Еритроцити (RBC) - 3,85 $\times 10^{12}/\text{л}$, Гемоглобін (HGB) - 102 г/л, Гематокрит (HCT) - 34,2 %, Тромбоцити (PLT) - 239 $\times 10^9/\text{л}$, Середній розмір еритроцита (MCV) - 88,8 ф/л, Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) - 26,5 п/г, Середня конц.гемоглобіну в еритроцитах (MCHC) - 298 г/л, ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПОПУЛЯЦІЇ ЛЕЙКОЦИТІВ (АНАЛІЗАТОР) - , Відносна к-ть нейтрофілів NEUT% - 73,3 %, Відносна к-ть



ТОВ "КАПІТАЛ"
Ліцензія МОЗ України
АГ №599781 від 17.01.2012

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Код закладу за ЗКПО: 32381903

Універсальна клініка Оберіг
Україна, 03057, м. Київ,
вул. Зоологічна, 3, корпус "в" і "г"

(044) 521-30-03
невідкладна допомога 3003

5213003@oberig.ua
www.oberig.ua

ВИПИСНИЙ ЕПІКРИЗ

Пациєнт: **Жерліцина Анастасія Станіславівна, 46 р.**

Стационарна картка № 00054

Дата: **25.01.2023**

лімфоцитів LYM % - 16,5 %, Відносна к-ть моноцитів MONO% - 9,8 %, Відносна к-ть еозинофілів EO % - 0 %, Відносна к-ть базофілів BASO % - 0,4 %, Абсолютна к-ть нейтрофілів NEUT # - 9,41 Г/л, Абсолютна к-ть лімфоцитів LYM # - 2,12 Г/л, Абсолютна к-ть моноцитів MONO # - 1,26 Г/л, Абсолютна к-ть еозинофілів EO # - 0 Г/л, Абсолютна к-ть базофілів BASO # - 0,05 Г/л, Розподіл еритроцитів за об'ємом, станд відхилення RDW-SD - 77,3 ф/л, Розподіл еритроцитів за об'ємом, коеф. варіації RDW-CV - 24,7 %, Розподіл тромбоцитів PDW - 11,4 ф/л, Середній об'єм тромбоцитів MPV - 9,8 ф/л, Коеф. великих тромбоцитів P-LCR - 25,2 %, Тромбокрит PCT - 0,23 %, ШОЕ (ESR), метод Вестергрена - 30 мм/год, ЛЕЙКОЦИТАРНА ФОРМУЛА (МАНУАЛЬНО) - , Паличкоядерні нейтрофіли (band neut%) - 5 %, Сегментоядерні нейтрофіли (segm.neut %) - 68 %, Моноцити (mon %) - 8 %, Лімфоцити (lym %) - 20 %;

19.01.2023...Електроліти крові

Електроліти крові (K+, Na+, Cl-): Na+ - 138,1 mmol/L, K+ - 5 mmol/L, Cl- - 106,7 mmol/L;

19.01.2023...D-дімер (кількісно) - маркер ТЕЛА та тромбозу глибоких вен

D-дімер (цитратна плазма) - 0,11 mg/L;

19.01.2023...Прокальцитонін - маркер гострих бактеріальних інфекцій та септичних станів

Прокальцитонін - < 0,1 ng/ml;

19.01.2023...Біохімічні дослідження

Аланінамінотрансфераза (ALT) - 58,50 U/L; Аспартатамінотрансфераза (AST) - 35,70 U/L; Гама-глутаматтрансфераза (GGT) - 109,00 U/L; Лужна фосфатаза (ALP) - 133,80 U/L; Лактатдегідрогеназа (LDH) - 313,30 U/L; Білірубін загальний (Bilirubin total) - 3,15 umol/L; Білірубін прямий (Bilirubin direct) - 1,50 umol/L; Холінестераза (CHE) - 5 419 U/L; Примітка - ;

19.01.2023...Визначення глікованого гемоглобіну HbA1c

Глікований гемоглобін (HbA1c): Глікований гемоглобін (NGSP)(середній рівень вмісту глюкози в крові за період життя еритроцитів за останні 2-3 місяці) - 6,59 %, Додаткова інформація: глікований гемоглобін використовується для скринінгу населення, а також для моніторингу лікування хворих на цукровий діабет - За рекомендаціями ВООЗ (2002р.) навіть незначні порушення вуглеводного обміну є фактором ризику судинних ускладнень. Рівень судинного ризику залежить від глікованого гемоглобіну, ЗАКЛЮЧЕННЯ - Можливий переддіабет (порушення вуглеводного обміну), зверніться до лікаря-ендокринолога, або терапевта.;

19.01.2023...Біохімічні дослідження

Залізо (Iron) - 8,59 umol/L; C- реактивний білок (кількісно) (CRP) - 6,81 mg/L; Примітка - ;

19.01.2023...Біохімічні дослідження

Трансферин: Залізо (Iron) - 8,59 nmol/L, Трансферин (Transferrin) - 3,37 g/l, Оцінка насичення трансферина залізом (TS) - 9,96 %;

23.01.2023...КЛІНІЧНИЙ АНАЛІЗ КРОВІ

Загальноклінічний аналіз крові (параметри аналізатора, лейкоцитарна формула): Лейкоцити (WBC) - 11,26 x10⁹/л, Еритроцити (RBC) - 3,7 x10¹²/л, Гемоглобін (HGB) - 100 г/л, Гематокрит (HCT) - 32,5 %, Тромбоцити (PLT) - 329 x10⁹/л, Середній розмір еритроцита (MCV) - 87,8 ф/л, Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) - 27 п/г, Середня конц.гемоглобіну в еритроцитах (MCHC) - 308 г/л, ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПОПУЛЯЦІЇ ЛЕЙКОЦИТІВ (АНАЛІЗАТОР) - , Відносна к-ть нейтрофілів NEUT% - 54,6 %, Відносна к-ть лімфоцитів LYM % - 28,7 %, Відносна к-ть моноцитів MONO% - 14,7 %, Відносна к-ть еозинофілів EO % - 1,7 %, Відносна к-ть базофілів BASO % - 0,3 %, Абсолютна к-ть нейтрофілів NEUT # - 6,15 Г/л, Абсолютна к-ть лімфоцитів LYM # - 3,23 Г/л, Абсолютна к-ть моноцитів MONO # - 1,66 Г/л, Абсолютна к-ть еозинофілів EO # - 0,19 Г/л, Абсолютна к-ть базофілів BASO # - 0,03 Г/л, Розподіл еритроцитів за об'ємом, станд відхилення RDW-SD - 76,6 ф/л, Розподіл еритроцитів за об'ємом, коеф. варіації RDW-CV - 25,7 %, Розподіл тромбоцитів PDW - 10,6 ф/л,



ТОВ "КАПІТАЛ"
Ліцензія МОЗ України
АГ №599781 від 17.01.2012

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Код закладу за ЗКПО: 32381903

Універсальна клініка
Україна, 03057, м. Київ,
вул. Зоологічна, 3, корпус "в" і "г"

(044) 521-30-03
невідкладна допомога 3003

5213003@oberig.ua
www.oberig.ua

ВИПИСНИЙ ЕПІКРИЗ

Пацієнт: **Жерліцина Анастасія Станіславівна, 46 р.**

Стационарна картка № 00054

Дата: **25.01.2023**

Середній об'єм тромбоцитів MPV - 9,5 ф/л, Коеф. великих тромбоцитів P-LCR - 21,9 %, Тромбоцит PCT - 0,31 %, ЛЕЙКОЦИТАРНА ФОРМУЛА (МАНУАЛЬНО) - , Паличкоядерні нейтрофіли (band neut%) - 2 %, Сегментоядерні нейтрофіли (segm. neut %) - 59 %, Моноцити (mon %) - 12 %, Лімфоцити (lym %) - 24 %, Еозинофіли (eo %) - 3 %, МОРФОЛОГІЯ ЕРИТРОЦИТІВ - , ДЕГЕНЕРАТИВНІ ЗМІНИ В ЛЕЙКОЦИТАХ - ;

23.01.2023...Біохімічні дослідження

Кальцій загальний, кальцій іонізований: Кальцій (Calcium) - 2,09 mmol/L, Кальцій іонізований (Ca++) - 1,05 mmol/L; С- реактивний білок (кількісно) (CRP) - 3,58 mg/L; Примітка - ;

23.01.2023...25-гідроксиколекаль-циферол (25-ОН вітамін Д)

25-гідроксиколекаль-циферол (25-ОН вітамін Д) - 20,9 нг/мл;

23.01.2023...Маркери функціонального стану щитоподібної залози

Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH) - 3,9 μ IU/mL;

РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: 13.01.2023...МРТ головного мозку (Ковратко М. М.)

ЖЕРЛІЦИНА А.С. МРТ головного мозку Номер дослідження: 3251 від 13.01.2023. Найменування закладу (його підрозділу), який направив хворого на дослідження: *самозвернення*. Дослідження виконано на: 1,5T MPT-системі Magnetom Semptra виробництва Siemens Healthcare. Контрастне підсилення: *використовувалось*. Клінічна задача: *з анамнезу – Са матки (лейоміосаркома)*. Медична документація не представлена.

Протокол дослідження: На серії МРТ головного мозку в лобних, тім'яних та потилично-скроневих ділянках з обох сторін виявляються дифузні зміни кортико-субкортикальної речовини, які характеризуються гіперінтенсивним на T2/T2_dark_fluid-WI та гіпоінтенсивним на T1-WI МР-сигналами, без ознак рестрикції дифузії при DWI/ADC та демонструють помірне дифузно-плямисте контрастне підсилення. При попередньому МР-дослідженні за 20.09.2022р. – дані зміни не визначались. Серединні структури без ознак латерального зміщення. Шлуночки мозку не розширені, бічні відносно симетричні. Мигдалини мозочка розташовані звичайно. Конвексимальні субарахноїдальні простори, цистерни латеральних щілин не розширені. Зміни інтенсивності МР-сигналу в гіпофізі і хіазмі, базальних гангліях, краніо-вертебральному переході і мосто-мозочкових кутах не виявлено. Очні яблука симетричні, ретробульбарні простори і зорові нерви виглядають звичайно. Пневматизація приносових синусів та соскоподібних відростків не змінена. Вогнищ агресивного характеру в кістках основи та склепіння черепа не виявлено.

ЗАКЛЮЧЕННЯ: З анамнезу – Са матки, стан після ПХТ. Виявлена МР-картина дифузно-вогнищевих змін кортико-субкортикальної речовини обох півкуль мозку, враховуючи гострий клінічний перебіг, потребує диференціації між проявами *запального / аутоімунного процесу (у т.ч. васкуліту)*, натомість вторинний *mts-генез* змін значно менш вірогідний. Окрім того, радіологічна МР-картина може бути подібною до проявів *CNS lymphoma*, однак беручи до уваги відсутність змін при DWI-послідовностях, вірогідність процесу є сумнівною. МР-даних за наявності вогнищ свіжого ПМК чи внутрішньо-мозкового крововиливу – не виявлено.

Рекомендовано: консультація невропатолога, онколога, радіологічно-лабораторна кореляція, короткий МРТ контроль після курсу кортикостероїдної терапії.

20.01.2023...МРТ головного мозку та інтра-екстракраніальних артерій з контрастуванням

ЖЕРЛІЦИНА А.С. МРТ головного мозку та інтра-екстракраніальних артерій з контрастуванням Номер дослідження: 7091 від 20.01.2023р. Найменування закладу, який направив хворого на дослідження: *стационар*. Дослідження виконано на: 3T MPT-системі VIDA виробництва Siemens Healthcare. Контрастне підсилення: *Дотавіст 14 мл, внутрішньовенно, 3 мл/сек*. Клінічна задача: *враховані дані попереднього МРТ від 13.01.2023р.*

ПРОТОКОЛ ЗАКЛЮЧЕННЯ МРТ ГОЛОВНОГО МОЗКУ МОЗКОВА ПАРЕНХІМА: Зберігаються дифузні зміни кортико-субкортикальної речовини в лобних, тім'яних та потилично-скроневих ділянках з обох сторін, із



ТОВ "КАПІТАЛ"
Ліцензія МОЗ України
АГ №599781 від 17.01.2012

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Код закладу за ЗКПО: 32381903

Універсальна клініка Оверіг

Україна, 03057, м. Київ,
вул. Зоологічна, 3, корпус "в" і "г"

(044) 521-30-03
невідкладна допомога 3003

5213003@oberig.ua
www.oberig.ua

ВИПИСНИЙ ЕПІКРИЗ

Пацієнт: **Жерліцина Анастасія Станіславівна, 46 р.**

Стационарна картка № 00054

Дата: **25.01.2023**

помірним зменшенням в динаміці проявів гіперінтенсивності кори на рівні лобних та скроневих часток, із резидуальним помірним дифузно-плямистим контрастним підсиленням. Наразі по корі обох тім'яних часток в парасагітальних відділах визначаються ділянки *цитотоксичного набряку* (3 од), протяжністю – до 8..20 мм. Окрім цього, лівій потиличній частці, на фоні виявлених раніше змін визначається вогнище *внутрішньо-мозкової геморагії*, розмірами – до 13x12x25 мм, оточене помірним перифокальним вазогенним набряком. Мезенцефальні структури, структури задньої черепної ями, стовбур мозку ділянок патологічної зміни МР сигналу не містять. Краніовертебральний перехід без особливостей. Ніякого мас-ефекту або зміщення серединних структур. ШЛУНОЧКИ та КОНВЕКСИТАЛЬНІ ЕКСТРААКСІАЛЬНІ ПРОСТОРИ: Немає гідроцефалії, шлуночки мозку не розширені, бічні відносно симетричні. ЕКСТРААКСІАЛЬНІ СТРУКТУРИ: Візуалізовані структури нормальні. **МРА ГОЛОВНОГО МОЗКУ:** Не виявлено аневризм. МРА показує нерівномірність судин передніх, середніх та задніх мозкових артерій з мультифокальними сегментами вазоспазму, що надає вигляду "нитки намистин" ("string-of-beads" appearance). **МРА ШІЙ:** ЗАГАЛЬНІ СТОВБУРИ: Візуалізовані сегменти є інтактними. ПРАВА ВСА: без стенозування by NASCET criteria at the carotid bifurcation. ЛІВА ВСА: без стенозування by NASCET criteria at the carotid bifurcation. ВЕРТЕБРАЛЬНІ АРТЕРІЇ: Типові екстракраніальні сегменти, D>S

ЗАКЛЮЧЕННЯ: МР-картина *дифузно-вогнищевих* змін кортико-субкортикальної речовини обох півкуль мозку, з переважанням змін в обох потиличних частках, із появою в динаміці вогнищ *цитотоксичного набряку* кори обох тім'яних часток, *внутрішньо-мозкової геморагії* лівій потиличної частки та ознак *церебральної васкулопатії* з мультифокальними стенотичними сегментами *вазоконстрикції*. Описані зміни, враховуючи гострий клінічний перебіг, типові та характерні для - **Синдрому задньої обратимої енцефалопатії (PRES)**, з внутрішньо-мозковим крововиливом та церебральною васкулопатією.

20.01.2023...УЗД ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ ТА ЗАОЧЕРЕВИННОГО ПРОСТОРУ (КОМПЛЕКСНЕ).

ПЕЧІНКА збільшена, товщина правої частки 140мм, лівої частки 100мм. Контури часток рівні, чіткі. Ехоструктура неоднорідна, дрібнозерниста на вільних ділянках, ехогенність паренхіми середня. У правій частці кістозно-солідний утвір ~ 16x12x15см з кістозними порожнинами до 10см у довжину. Аналогічної будови утвір на межі правої та лівої часток ~5см у d. У режимах колоризації аваскулярні. Внутрішньопечінкові жовчні протоки при УЗД не визначаються. V.Portae не розширена. Печінкові вени, НПВ, черевний відділ аорти не змінені. ЖОВЧНИЙ МІХУР та загальна жовчна протока у доступних режимах сканування не визначається. ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА. Візуалізація задовільна. Розміри відповідають нормативним значенням: 24x15x21мм. Контури рівні, чіткі. Ехогенність паренхіми середня. Структура однорідна дрібнозерниста. Вірсунгова протока не розширена. У каудальному від хвоста напрямку визначається аваскулярний гіпоехогенний утвір ~5см, неправильної овальної форми з чіткими рівними контурами, однорідної гіпоехогенної структури. СЕЛЕЗІНКА не збільшена, 99x35мм. Контури рівні чіткі, ехогенність середня, структура однорідна. Вільна рідина в черевній порожнині визначається у н/поверхах товщиною шару до 2,5см. НИРКИ вікових розмірів, розташовані типово. Дихальна рухливість збережена. Форма не змінена, контури рівні, чіткі. Паренхіма середньої ехогенності. Вогнищеві зміни не виявлені. Кортико-медулярна диференціація збережена. Васкуляризація не змінена. Товщина паренхіми відповідає віковим нормативним значенням. Збиральна система не розширена. ПРАВА НИРКА: 117x58мм. ЛІВА НИРКА: 119x59мм.

ЗАКЛЮЧЕННЯ: УЗ-ознаки вогнищевих змін печінки, малого гідроперитонеуму, mts?черевної порожнини. Гепатомегалія.

КОНСУЛЬТАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ: 16.01.2023...КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ВИСНОВОК ЗАВІДУВАЧА ІНСУЛЬТНИМ ЦЕНТРОМ, КАНДИДАТА МЕДИЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТА, ЗАСЛУЖЕНОГО ЛІКАРЯ УКРАЇНИ Ю.В.

ВИСНОВОК. Зважаючи на тісний часовий зв'язок між неврологічними порушеннями та початком лікування препаратом Вотрієнт та зазанчену в інструкції цього препарату можливість таких побічних ефектів, як головний біль, підвищення АТ, судоми та синдром задньої обратимої енцефалопатії, найбільш імовірною причиною розладів пацієнтки синдром задньої обратимої енцефалопатії (Posterior reversible encephalopathy syndrome -



ТОВ "КАПІТАЛ"
Ліцензія МОЗ України
АГ №599781 від 17.01.2012

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Код закладу за ЗКПО: 32381903

Універсальна клініка Оберіг,
Україна, 03057, м. Київ,
вул. Зоологічна, 3, корпус "в" і "г"

(044) 521-30-03
невідкладна допомога 3003

5213003@oberig.ua
www.oberig.ua

ВИПИСНИЙ ЕПІКРИЗ

Пацієнт: **Жерліцина Анастасія Станіславівна, 46 р.**

Стационарна картка № 00054

Дата: **25.01.2023**

PRES) як побічного ефекту лікування Вотрієнтом. Диференційний діагноз слід проводити з іншими підгострими лейкоенцефалопатіями, зокрема автоімунної та токсичної природи, та синдромом обратимої церебральної вазоконстрикції (Reversible cerebral vasoconstriction syndrome - RCVS).

РЕКОМЕНДОВАНО: : 1. Припинити прийом Вотрієнта.

2. Розглянути можливість пульс-терапії метилпреднізолоном (500 мг в/в 1 раз на добу вранці N3) з корекцією можливої гіпертензії, гіпеглікемії чи електролітних порушень.

3. Повторне проведення МРТ головного мозку з МРА екстра- та інтракраніальних артерій через 1 тиждень після першого дослідження (20.01.2023).

4. Консультація хіміотерапевта щодо подальшого лікування.

5. Повна відмова від куріння.

20.01.2023...КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ВИСНОВОК ЕНДОКРИНОЛОГА, ЗАСЛУЖЕНОГО ЛІКАРЯ УКРАЇНИ (Таран Л. Ф.)

ДІАГНОЗ (висновок спеціаліста):: Цукровий діабет, не виключено, індукований глюкокортикоїдами, вперше виявлений в стані субкомпенсації (на даний час на тлі застосування глюкокортикоїдів.).

РЕКОМЕНДОВАНО: : **ОБСТЕЖЕННЯ:**

1. Тиреотропний гормон
2. 25-гідроксिवітамін D, 25-(ОН)D
3. Кальцій загальний, кальцій іонізований
4. Контроль глікемії 7,11,15,20 год
5. **Контроль рівня глюкози крові та глікогемоглобіну через 3 міс.**
6. Повторний огляд через 3 міс.

ЛІКУВАННЯ:

7. Діабетична дієта
8. **Глюкофаж XR 1000мг** по 1/2 табл. ввечері після їжі 1 тиждень, потім по 1 таб ввечері після їжі 1 тиж., потім по 1,5 таб ввечері після їжі 1 тиждень, потім по 2 таб ввечері після їжі постійно до наступного візиту до ендокринолога
9. **У разі високих показників глікемії - Форксіга** (дапагліфлозин) **або Джардінс** (емпагліфлозин): по 10 мг зранку незалежно від прийому їжі постійно до наступного візиту до ендокринолога
10. **Інсулін Актрапід** по 4-8 од при гіперглікемії вище 10 ммоль/л.
11. Декристал Д3 в таблетках по 4000 од по 1 таб 1 раз на добу **до квітня включно**

23.01.2023...КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ВИСНОВОК ЗАВІДУВАЧА ІНСУЛЬТНИМ ЦЕНТРОМ, КАНДИДАТА МЕДИЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТА, ЗАСЛУЖЕНОГО ЛІКАРЯ УКРАЇНИ Ю.В. ФЛОМІНА (Фломін Ю. В.)

ВИСНОВОК. Найбільш імовірною причиною розладів пацієнтки є синдром задньої обратимої енцефалопатії (Posterior reversible encephalopathy syndrome - PRES) як побічного ефекту лікування Вотрієнтом.

РЕКОМЕНДОВАНО: :

1. Відмовитись від лікування Вотрієнтом.



ТОВ "КАПИТАЛ"
Ліцензія МОЗ України
АГ №599781 від 17.01.2012

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Код закладу за ЗКПО: 32381903

Універсальна клініка Оберіг

Україна, 03057, м. Київ,
вул. Зоологічна, 3, корпус "в" і "г"

(044) 521-30-03
невідкладна допомога 3003

5213003@oberig.ua
www.oberig.ua

ВИПИСНИЙ ЕПІКРИЗ

Пацієнт: **Жерліцина Анастасія Станіславівна, 46 р.**

Стационарна картка № 00054

Дата: **25.01.2023**

- Повна відмова від куріння.
- Додати до лікування Аспірин кардіо 100 мг 1 раз на добу - тривало, а також Кетилепт 25 мг 1 раз на добу на ніч - 1 тиждень
- Збільшити рухову активність (не менше ніж 3-4 тис. кроків на день).
- Спостереження онколога, розглянути питання про тривалу медикаментозну профілактику венозних тромбозів та тромбоемболій.

24.01.2023...КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ВИСНОВОК ОНКОГІНЕКОЛОГА (Єфіменко А.А.)

СКАРГИ: : на момент огляду:

АНАМНЕЗ ЗАХВОРЮВАННЯ: : 28.08.2022 за даними біопсії встановлено діагноз: лейоміосаркоми матки T2NxM1(печінка, очеревина), (гістологічне дослідження трепан-біоптату метастатичного вогнища печінки, опис сумнівний, ІГХ не проводилося) Отримала курси ПХТ(гемцитабін+доцетакс+авастин), наразі застосовує Пазопоніб(Вотрієнт) 800мг/добу з 05.01.23, на 2-3 день вперше відмітила головний біль та підвищення артеріального тиску до 150-160 мм рт ст, еліквіс 2,5мг/добу, також призначені несистематично антигіпертензивні та НПЗП з приводу головних болей. 13.01.2023 госпіталізована в стаціонар клініки Оберіг з генералізованим нападом судом, проведено МРТ мозку, консультована завідувачем інсультним центром, к.м.н., заслуженим лікарем України Фломіним, виявлено синдром задньої оборотної енцефалопатії (Posterior reversible encephalopathy syndrome - PRES) як побічного ефекту лікування Вотрієнтом Спрямована на консультацію до онкогинеколога

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ::

АНАМНЕЗ ЖИТТЯ:: **Гінекологічний анамнез.** Менструації з 11 років, по 5-7 днів, через 28 днів: помірні, без болю. Остання менструація та її характер: медикаментозна менопауза

Кількість вагітностей: 0	Пологів - 0	Абортів -	Викиднів -
-----------------------------	-------------	-----------	------------

Контрацепція: - Операції: апендектомія в дитинстві Соматичний анамнез: черепно-мозкова травма, хвороба Боткіна в 2002 році Сімейний онкологічний анамнез обтяжений - у матері рак тіла матки в 68 років

ДАНІ ОБ'ЄКТИВНОГО ОГЛЯДУ: : **Зовнішні статеві органи:** без особливостей **Промежина:** без змін **Піхва:** вузька. **Стінка піхви:** без змін. **Шийка матки:** без змін, конічної форми. **Зовнішнє вічко:** округле. **Виділення:** слизові. **P.V:** Шийка матки циліндрична, конічна. В малому тазу пальпується об'ємне утворення з чіткими контурами загальними розмірами 9x14 см, нерухоме, болсне. Параметрії не інфільтровані.

ДІАГНОЗ (висновок спеціаліста)::[C55] **Злоякісне новоутворення матки, не уточненої локалізації сT2NxM1 (печінка, очеревина) клінічна група IV ECOG 2 (морфологічні верифікація сумнівна через відсутність проведеного імуногістохімічного дослідження та виявлення в пухлині специфічних рецепторів EGFR)**

РЕКОМЕНДОВАНО:: Взята трепан-біопсія метастатичного вогнища печінки, після отримання гістологічного дослідження та ІГХ вирішити питання щодо подальшого ведення. До призначення таргетної препаратом інгібіторів тирозинкінази (Пазопаніб) не повертатися.



ТОВ "КАПІТАЛ"
Ліцензія МОЗ України
АГ №599781 від 17.01.2012

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Код закладу за ЗКПО: 32381903

Універсальна клініка Оберіг
Україна, 03057, м. Київ,
вул. Зоологічна, 3, корпус "в" і "г"

(044) 521-30-03
невідкладна допомога 3003

5213003@oberig.ua
www.oberig.ua

ВИПИСНИЙ ЕПІКРИЗ

Пацієнт: **Жерліцина Анастасія Станіславівна, 46 р.**

Стационарна картка № 00054

Дата: **25.01.2023**

ПРОВЕДЕНЕ ЛІКУВАННЯ: Пульс- терапія Солюмедрол 500 мг в/в на фізрозчині 200,0 протягом трьох днів з 17.01.2023 по 19.01.2023, дексаметазон 12 мг в/в крап з поступовим зниженням дози, динонстат 40 мг в/в, клексан 0,4 п/ш 1 раз на добу, таб амлодипін 5 мг ввечері, проксіум 40 мг, таб глюкофаж 500 мг ввечері.

24.01.2023 проведена черезшкірна трепанбіопсія вогнища печінки під контролем УЗ, матеріал відправлено на гістологічне дослідження.

РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ: покращення.

РЕКОМЕНДОВАНО: Спостереження сімейного лікаря.

Спостереження онколога, розглянути питання про тривалу медикаментозну профілактику венозних тромбозів та тромбоемболій.

Взята трепан-біопсія метастатичного вогнища печінки, після отримання гістологічного дослідження та ІГХ вирішити питання щодо подальшого ведення.

До призначення таргетної препаратами інгібіторів тирозинкінази (Пазопаніб) не повертатися.

1. ЛІКУВАННЯ:

2. Діабетична дієта. Збільшити рухову активність (не менше ніж 3-4 тис. кроків на день).

3. **Глюкофаж XR 1000мг** по 1/2 табл. ввечері після їжі 1 ще 2 дні, потім по 1 таб ввечері після їжі 1 тиж., потім по 1,5 таб ввечері після їжі 1 тиждень, потім по 2 таб ввечері після їжі постійно до наступного візиту до ендокринолога

4. **У разі високих показників глікемії - Форксіга** (дапагліфлозин) **або Джардінс** (емпагліфлозин): по 10 мг зранку незалежно від прийому їжі постійно **до наступного візиту до ендокринолога**

5. **Аспірин кардіо 100 мг 1 раз на добу - тривало**, а також **Кетилепт 25 мг 1 раз на добу на ніч - 1 тиждень**

6. **Декристал ДЗ** в таблетках по 4000 од по 1 таб 1 раз на добу **до квітня включно.**

7. **Клексан 0,4 п/ш 1 раз на день.**

8. **Кальцій-Д3-нікомед-остеофорте** 1 таб ввечері - 3 місяці.

9. **Гептрал** таб 500 мг 1 таб двічі на день між прийомами їжі (08:00 ранку та 16:00) протягом 1 місяця.

10. Таб **проксіум** 40 мг 1 таб зранку до сніданку протягом 3 тижнів.

Лікуючий лікар: Антонюк Л. І.

Зав. відділенням: Юрків Олег Євгенович

Мені в зрозумілій формі були надані рекомендації щодо лікування і необхідності його дотримання.

підпис



ТОВ "КАПІТАЛ"
Ліцензія МОЗ України
АГ № 599781 від 17.01.2012

Універсальна клініка "Оберіг"

Україна, 03057, м. Київ,
вул. Зоологічна, 3, корпус "В"

тел. (044) 521-30-03
факс (044) 521-03 42

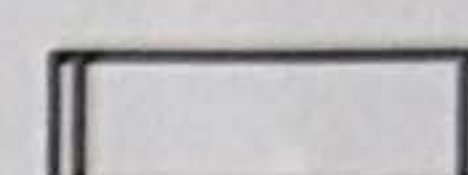
5213003@oberig.ua
www.oberig.ua

Результати досліджень

Дата замовлення: 17/01/2023 № замовл.: 28939327
Пацієнт: **Жерліцина Анастасія Станіславівна**
Дата народження: 25.04.1976 Контракт: Оберіг клініка Київ
Вік: 46 Y 8 M Пункт: Автоімпорт Корп.Кабінет
Стать: Жіноча Лікар:



Штрих-код: 3004233018



Індикатор зони
підвищеної уваги

Показник	Результат	Од.	Референтний інтервал
----------	-----------	-----	----------------------

Імунологія-ELISA

Антинуклеарні антитіла (ANA, метод IFT)	1:100	Титр	< 1:100 - негативний результат
Пакет №5.11 (ANCA - антитіла IgG)			
Лактоферин, антитіла IgG_ANCA	< 0.1	R	<1.0 - негативний результат ≥1.0 - <2.0 - слабо позитивний результат ≥2.0 - <5.0 - позитивний результат ≥5.0 - сильно позитивний результат Метод: Імуноферментний аналіз (ІФА, ELISA) Реагенти: Euroimmun (Німеччина) Аналізатор: EUROIMMUN Analyzer I (Німеччина)
Нейтрофільна еластаза, антитіла IgG_ANCA	< 0.1	R	<1.0 - негативний результат ≥1.0 - <2.0 - слабо позитивний результат ≥2.0 - <5.0 - позитивний результат ≥5.0 - сильно позитивний результат Метод: Імуноферментний аналіз (ІФА, ELISA) Реагенти: Euroimmun (Німеччина) Аналізатор: EUROIMMUN Analyzer I (Німеччина)
Катепсин G, антитіла IgG_ANCA	< 0.1	R	<1.0 - негативний результат ≥1.0 - <2.0 - слабо позитивний результат ≥2.0 - <5.0 - позитивний результат ≥5.0 - сильно позитивний результат Метод: Імуноферментний аналіз (ІФА, ELISA) Реагенти: Euroimmun (Німеччина) Аналізатор: EUROIMMUN Analyzer I (Німеччина)
Бактерицидний білок, підвищуючий проникність (BPI), антитіла IgG_ANCA	0.2	R	<1.0 - негативний результат ≥1.0 - <2.0 - слабо позитивний результат ≥2.0 - <5.0 - позитивний результат ≥5.0 - сильно позитивний результат Метод: Імуноферментний аналіз (ІФА, ELISA) Реагенти: Euroimmun (Німеччина) Аналізатор: EUROIMMUN Analyzer I (Німеччина)
Мієлопероксидаза (MPO), антитіла IgG_ANCA	0.8	R	<1.0 - негативний результат ≥1.0 - <2.0 - слабо позитивний результат ≥2.0 - <5.0 - позитивний результат ≥5.0 - сильно позитивний результат Метод: Імуноферментний аналіз (ІФА, ELISA) Реагенти: Euroimmun (Німеччина) Аналізатор: EUROIMMUN Analyzer I (Німеччина)

Результати лабораторних досліджень не є достатньою підставою для постановки діагнозу.
Інтерпретація результатів та постановка діагнозу виконується тільки лікарем.

Обробка матеріалу та видача результатів аналізів виконується за допомогою лабораторної інформаційної системи SILAB.



ТОВ "КАПІТАЛ"
Ліцензія МОЗ України
АГ № 599781 від 17.01.2012

Універсальна клініка "Оберіг"

Україна, 03057, м. Київ,
вул. Зоологічна, 3, корпус "В"

тел. (044) 521-30-03
факс (044) 521-03 42

5213003@oberig.ua
www.oberig.ua

Результати досліджень

Дата замовлення: 17/01/2023 № замовл.: 28939327
Пацієнт: **Жерліцина Анастасія Станіславівна**
Дата народження: 25.04.1976 Контракт: Оберіг клініка Київ
Вік: 46 Y 8 M Пункт: Автоімпорт Корп.Кабінет
Стать: Жіноча Лікар:



Штрих-код: 3004233018



Індикатор зони
підвищеної уваги

Показник	Результат	Од.	Референтний інтервал
Протеїназа 3 (PR3), антитіла IgG_ANCA	< 0.1	R	<1.0 - негативний результат ≥1.0 - <2.0 - слабо позитивний результат ≥2.0 - <5.0 - позитивний результат ≥5.0 - сильно позитивний результат Метод: Імуноферментний аналіз (ІФА, ELISA) Реагенти: Euroimmun (Німеччина) Аналізатор: EUROIMMUN Analyzer I (Німеччина)

Примітка:

Дмитренко О.В.

Результати лабораторних досліджень не є достатньою підставою для постановки діагнозу.

Інтерпретація результатів та постановка діагнозу виконується тільки лікарем.

Обробка матеріалу та видача результатів аналізів виконується за допомогою лабораторної інформаційної системи SILAB.